

Континентная кожная деривация — это внутренний резервуар из собственного кишечника, который удерживает мочу внутри тела. Небольшое герметичное отверстие (стома, часто в области пупка) позволяет опустошать резервуар катетером несколько раз в день — без наружного мешка. Indiana Pouch является наиболее распространённым вариантом.

Об этой операции

Фрагмент **толстой и тонкой кишки** преобразуется в низкодавливающий **резервуар** в брюшной полости; мочеточники (трубки от почек) впадают в него. Короткий канал с **клапаном** выводится на кожу — обычно в **пупок** — в виде небольшой плоской стомы, которая остаётся сухой между катетеризациями.

- Резервуар опустошают катетером примерно **каждые 4–6 часов**.
- Резервуар нужно **промывать (ирригировать)** для удаления слизи.
- **Без мешка** — только небольшая прокладка или повязка на стому.

Операция подходит тем, кто не хочет носить мешок, не является кандидатом на неовезикулопластику (или отдаёт предпочтение другому варианту) и способен **регулярно выполнять катетеризацию** — что требует устойчивых рук и нормального зрения либо помощника.

Это безопасно?

Это хорошо изученный метод континентной деривации. Операция крупнее и длительнее, чем кондуит, и требует пожизненной катетеризации. Возможные риски: хирургические осложнения (кровотечение, инфекция, несостоятельность швов), трудности с катетеризацией или сужение/подтекание стомы (иногда требующие коррекции), камни в резервуаре, слизь, инфекции мочевыводящих путей (UTI), а также долгосрочные изменения электролитного баланса, уровня витаминов и функции почек, контролируемые на плановых осмотрах.

ТЕРМИНЫ

Континентная деривация

Система отведения мочи, при которой она не вытекает — пациент сам контролирует опустошение.

Indiana Pouch

Наиболее распространённый континентный резервуар из правой части толстой кишки и тонкой кишки.

Резервуар (pouch)

Внутренний мешок из кишечника для хранения мочи.

Стома

Небольшое кожное отверстие (часто пупок), через которое вводят катетер.

Катетеризация

Введение тонкой трубки через стому для опустошения резервуара.

Ирригация

Промывание резервуара водой для удаления слизи.

Мочеточники

Трубки, несущие мочу от почек; впадают в резервуар.

Слизь

Вязкий секрет кишечника; регулярное удаление — часть ежедневного ухода.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Операция проводится под общей анестезией — во время неё вы ничего не почувствуете. После неё ожидайте болезненности в животе; кишечник «просыпается» несколько дней. Вы просыпаетесь с дренажной трубкой в резервуаре (и мягкими стентами), которая остаётся около 3–4 недель на период заживления — её регулярно промывают для удаления слизи. Большинство пациентов выписывается через 5–8 дней.

Как подготовиться (до операции)

- Операция проводится под **общей анестезией** — соблюдайте все предписания (голодание, отмена антикоагулянтов по указанию врача). Может потребоваться **подготовка кишечника**.
- Команда определит **место стомы** (обычно пупок) и убедится, что вы или ваш помощник способны выполнять **пожизненную катетеризацию**.
- Не курите** и заранее организуйте помощь дома после выписки.

Сообщите команде заранее, если вы:

- Принимаете **антикоагулянты** или имеете активную инфекцию
- Страдаете **заболеванием кишечника**, проблемами с почками или имеете трудности с **руками или зрением**, влияющие на катетеризацию

Что происходит во время операции

- 1 Вы погружены в анестезию; вводятся антибиотики.
- 2 Выделяется фрагмент кишечника; оставшаяся часть соединяется.
- 3 Из кишечника формируется резервуар, а катетеризируемый канал с клапаном выводится на кожу в виде стомы.
- 4 Присоединяются мочеточники; на период заживления устанавливаются дренажная трубка и мягкие стенты.

После операции

- Выписка через **5–8 дней с дренажной трубкой на ~3–4 недели**; регулярно промывайте её для удаления слизи.
- После извлечения трубки — **катетеризация стомы каждые 4–6 часов** и ирригация для удаления слизи.
- Стома остаётся **сухой** — небольшая прокладка или повязка (без мешка). Слизь — норма; пейте достаточно жидкости; **избегайте нагрузок ~6 недель**; пожизненное наблюдение (витамин B12, контроль резервуара).

Срочно обратитесь за помощью, если у вас:

- Не удаётся ввести катетер или моча не выходит** — резервуар может переполниться, его нужно срочно опустошить
- Повышение температуры или озноб
- Сильная боль в животе, рвота или **отсутствие газов и стула**
- Обильное кровотечение, сгустки, блокирующие катетер, или покраснение и выделения из раны

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Континентный резервуар (Indiana Pouch) хранит мочу внутри тела; небольшое герметичное отверстие опустошается катетером, без мешка.
2. Вы будете катетеризировать стому каждые 4–6 часов и промывать резервуар пожизненно — нужны устойчивые руки, зрение или помощник.
3. Соблюдайте голодание и подготовку кишечника, не курите, организуйте помощь на время восстановления.